



ВИКЛИКИ 2022-2023 У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: на що звернути увагу ОМС при плануванні реалізації повноважень

Інформаційна сесія | 18 жовтня 2022 року



Міністерство
цифрової трансформації
України



Міністерство розвитку
громад та територій України

Про що будемо говорити

1. Основні принципи формування та кластеризації госпітальних округів в рамках інфраструктурного етапу реформи системи охорони здоров'я
2. ЕСОЗ - основа для контрактування, оплати та моніторингу НСЗУ
3. Підходи до управління закладами охорони здоров'я з огляду на інфраструктурний етап реформи системи охорони здоров'я
4. Індикатори визначення ефективності роботи ЗОЗ для ОМС на основі знеособлених електронних медичних даних
5. Питання та відповіді

Сьогодні з вами



Спікерка

Аліса Макаріхіна

Зовнішня експертка «U-LEAD з Європою»



Основні принципи формування та кластеризації госпітальних округів в рамках інфраструктурного етапу реформи системи охорони здоров'я

Запитання до учасників:

Власниками яких закладів охорони здоров'я є наразі ваша громада?

1

Первинна
ланка

2

Вторинна
ланка

3

Спеціалізований
заклад

4

Не є
власником ЗОЗ

Нормативно-правові акти

1. [Закон України від 03.12.2020 р. № 1053-IX «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я»](#)
2. [Закон України від 03.07.2020 р. № 749-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу у сфері охорони здоров'я»](#)
3. [Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»](#)
4. [Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних»](#)
5. [Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV](#)
6. [Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»](#)
7. [Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я»](#)

[ЗАКОН УКРАЇНИ від 01.07.2022 р. № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги»](#)

Набуття чинності, 19.07.2022 р.

Госпітальний округ, кластер та класифікація лікарень

[Частина перша стаття 3
Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров'я»](#)



Госпітальний округ

Територія, у межах якої забезпечено надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнтів медичної та реабілітаційної допомоги шляхом організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я

Кожна область - єдиний госпітальний округ.





Межі госпітальних округів та госпітальних кластерів

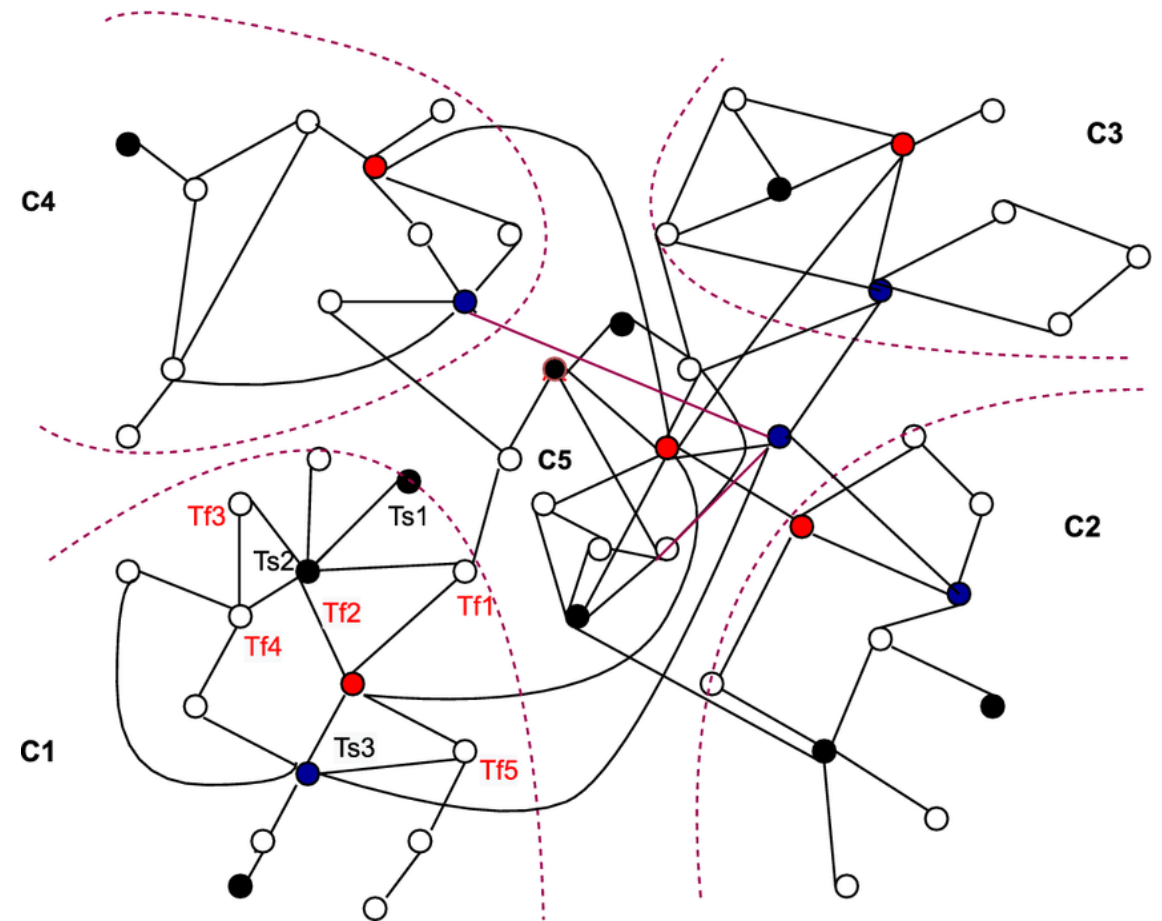
Межі госпітальних округів та госпітальних кластерів, порядок їх визначення та функціонування, а також порядок визначення кластерних, надкластерних та інших видів закладів охорони здоров'я, що входять до спроможної мережі госпітального округу, визначаються Кабінетом Міністрів України на основі потреб населення у медичній допомозі та забезпеченні комплексного надання медичної допомоги

Госпітальний кластер

Територія у межах госпітального округу з населенням від 150 тис. та радіусом доїзду до 90 хв, у межах якої забезпечено надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнтів медичної та реабілітаційної допомоги шляхом **організації спроможної мережі** закладів охорони здоров'я.

Кластери не визначаються межами адміністративних одиниць!

Кількість кластерів у межах госпітального округу формується за результатами аналізу потреб населення у медичних послугах.





Кластеризація - основа маршруту пацієнта

Маршрутизація пацієнта - це алгоритм, згідно якого пацієнта транспортують у ЗОЗ, у якому є можливість надати необхідний обсяг екстреної медичної допомоги при відповідному невідкладному стані

Нова типологізація лікарень

Статус, що чітко встановлює роль лікарні у критичній медичній інфраструктурі

НАДКЛАСТЕРНА
Найпотужніша/ші
лікарні регіону

КЛАСТЕРНА
мінімально
150 тис. населення

ЗАГАЛЬНА
40-80 тис. населення

Загальна лікарня (проект)

40-80 тис. населення

- Базові послуги
- Багатопрофільність
- Реабілітація

Кардіологія?

6-11 медичних сервісів:

- Терапія + Інтенсивна терапія (I, II)
- Загальна хірургія
- Неврологія
- Травматологія та ортопедія
- Педіатрія
- Паліатив
- Гінеколог
- Акушерство* (I)
- Інфекційні захворювання*
- Сестринський догляд*

Кластерна лікарня (проєкт)

Мінімально 150 тис. населення

- Широкий спектр послуг
- Багатопрофільність
- Готовність до реагування на критичні стани

Від 13 медичних сервісів:

- Кардіологія
- Дитяча хірургія
- Педіатрія
- Акушерство
- Гінекологія +ІТ новонароджених
- Офтальмологія
- Отоларингологія
- Психіатрія
- Терапія + ІТ (II)
- Неврологія
- Травматологія та ортопедія (II)
- Реабілітація
- Інфекційні захворювання

Надкластерна лікарня (проєкт)

Від 21 медичного сервісу:

- Нейрохірургія
- Кардіохірургія
- Судинну хірургія
- Щелепна-лицьова хірургія
- Комбустіологія
- Гематологія
- Пульмонологія
- Ендокринологія
- Гастроенторологія
- Дерматологія
- Онкологія
- Дитяча хірургія
- Акушерство
- Гінекологія +ІТ новонароджених
- Офтальмологія
- Отоларингологія
- Психіатрія
- Терапія + ІТ (III) нефрологія, ревматологія, алергологія, імунологія
- Неврологія
- Травматологія та ортопедія (II)
- Реабілітація
- Інфекційні захворювання
- ТБ

Найскладніші та найрідкісніші випадки!



Що береться до уваги, окрім спеціалізації

- Потужність лікарні – кількість наданих послуг
- Наявність медичних кадрів, їх кваліфікація та навантаження
- Наявність обладнання
- Як застосовується обладнання
- Показники якості наданих послуг

Лікарняна мережа європейського зразка

- 215** загальних лікарень (50-80 тис. нас.)
- 165** кластерних лікарень (150-250 тис. нас.)
- 52** надкластерні лікарні (багатопрофільні обласні)
- 6** міжрегіональних реабілітаційних центрів
- 5** міжрегіональних Центрів опікової травми та реконструктивної хірургії
- 10** університетських лікарень
- 10** національних проектів

1. Оцінка збитків
2. Визначення потреб населення у медичній допомозі
3. Роль лікарні в мережі: національні, надкластерні, кластерні, загальні та інші
4. План розвитку госпітальних округів
5. Плани розвитку лікарень
6. ПКД та бюджет розвитку
7. Будівництво та реконструкція

Роль МОЗ України - координуючий орган, відповідальним за розробку стратегічного бачення та нагляд за реконструкцією та будівництвом мережі лікарень

СТАДІЇ ВІДНОВЛЕННЯ

2022-
2023

Забезпечення медичною
допомогою під час війни

- Ургентна допомога
- Відновлення медичних послуг на деокупованих територіях
- Оцінка пошкодженої інфраструктури
- Регіональні госпітальні плани
- Збереження кадрового потенціалу - гідна з/п
- Відправлення пацієнтів за кордон

2023-
2025

Відновлення системи
охорони здоров'я

- Розвиток лікарень
спроможної мережі
- Інвестиції у мережу
- Доступні послуги з реабілітації та психічного здоров'я
- Гармонізація законодавства з ЄС
- Агенція з якості
- Національний провайдер лікарських засобів
- Депаперизація та нові електронні сервіси для пацієнтів

2023-
2026

Підвищення людського капіталу,
якості медичної допомоги,
технологічний розвиток

- Розвинута спроможна мережа лікарень
- Мережа університетських лікарень та нова якість освіти
- Центри психологічної реабілітації
- Психіатричні центри — зміна парадигми
- Ефективна мережа центрів контролю та профілактики хвороб
- Створена мережа центрів крові
- Розвиток медичного туризму
- ІТ-інновації та технології штучного інтелекту в медицині
- Національний фармацевтичний сектор — лідер економіки України

РЕАБІЛІТАЦІЯ

Нова мережа реабілітаційних послуг

- 6 нових міжрегіональних реабілітаційних центрів на базі шпиталів ветеранів або лікарень відновного лікування
 - Реабілітаційна допомога інтегрується до кожної кластерної та надкластерної лікарні
- Потреба інвестицій – 24 млн євро

Маршрутизація та спеціалізовані відділення

- 1. Спеціалізовані відділення / заклади:**
спінальна травма, важка черепно- мозкова травма, опіки, ампутації (в/кінцівки, тетра-, три- ампутації)
- 2. Гостра реабілітація** -
разом з медичною допомогою (кластерні/ надкластерні лікарні)

Фінансування

- ПМГ (перерахунок тарифів, розділення тарифів на стаціонарну та амбулаторну реабілітацію, зміна методів фінансування)
- Реімбурсація медичних виробів (включаючи допоміжні засоби)

- 3. Післягостра реабілітація** - стаціонарне реабілітаційне відділення кластерної/ надкластерної лікарні та / або регіональна реабілітаційна лікарня + амбулаторні реабілітаційні заклади/відділення
- 4. Довготривала реабілітація** - стаціонарні реабілітаційні відділення шпиталів ветеранів війни / реабілітаційні центри / лікарні відновного лікування / санаторні заклади



КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

- Зменшення частки витрат населення в загальних видатках на охорону здоров'я до 30%
- Зменшення на 35% неформальних платежів
- Управління мережею через ПМГ
- Зростання добровільного медичного страхування до 5% загальних видатків на ОЗ

Переваги для лікарень

- впровадження багаторічних договорів по ПМГ (можливість планувати бюджети)
- гарантоване фінансування відповідно до ролі в спроможній мережі
- залучення додаткових коштів через платні послуги, ДМС, інвестиції



Яка роль місцевого самоврядування?

Органи місцевого самоврядування здійснюють **планування розвитку мережі закладів охорони здоров'я комунальної форми власності**, приймають рішення про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров'я **з урахуванням затвердженого у встановленому порядку плану розвитку госпітального округу.**

Хто розробляє та приймає план розвитку госпітального округу?



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2019 р. № 1074
Київ

Деякі питання створення госпітальних округів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
[№ 589 від 19.06.2020](#)}

Відповідно до [частини четвертої](#) статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я Кабінет Міністрів України **постановляє**:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ [№ 589 від 19.06.2020](#)}

1. Затвердити такі, що додаються:

[Порядок створення госпітальних округів](#).

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ [№ 589 від 19.06.2020](#)}

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям забезпечити функціонування госпітальних округів у порядку, встановленому цією постановою.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити госпітальні ради.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ [№ 589 від 19.06.2020](#)}

4. Визнати такою, що втратила чинність, [постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 932](#) "Про затвердження Порядку створення госпітальних округів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3218).

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73

- Склад госпітальної ради визначається або змінюється обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим з урахуванням положень цього пункту
- Склад госпітальної ради не може перевищувати 21 особу

Склад госпітальної ради – 17 з 21 представників є обов'язковими!

До складу госпітальної ради входять представники державних органів, **органів місцевого самоврядування**, підприємств, установ, організацій, у тому числі представники:

- обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим - не менше трьох осіб
- обласної, Київської чи Севастопольської міської ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим - не менше двох осіб
- закладів охорони здоров'я або фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що надають первинну медичну допомогу, - не менше двох осіб
- закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та/або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, - не менше п'яти осіб
- закладів громадського здоров'я - одна особа або більше
- закладів охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу, - одна особа або більше
- професійних спілок працівників охорони здоров'я - одна особа або більше
- громадськості (громадських об'єднань, які представляють інтереси пацієнтів, та/або інших громадських об'єднань) - не менше двох осіб

Запитання до учасників:

Чи знаєте ви, хто представляє інтереси місцевого самоврядування у госпітальній раді вашого округу?

1

Так, знаю

2

Ні, не знаю

Запитання до учасників:

Чи вважаєте ви необхідним посилити роль місцевого самоврядування у діяльності рад госпітального округу?

1

Так, вважаю

2

Ні, не вважаю

3

Важко відповісти

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

- Що буде зі спеціалізованими ЗОЗ, які не потраплять у спроможну мережу?
- Що буде із вузькоспеціалізованими закладами?
- Чи будуть передивлятися спроможність мережі ЗОЗ?
- Де місце стоматологічній службі?
- Об'єднувати чи роз'єднувати заклади первинного та вторинного рівня?

На що ще треба звернути увагу?

1. Оплата праці у державних та комунальних закладах охорони здоров'я встановлюється у розмірі не нижчому, ніж визначено Кабінетом Міністрів України
2. Наглядові ради
3. Захист персональних даних та лікарської таємниці працівниками, що мають до них доступ
4. Закріплено право доступу НСЗУ до записів ЕСОЗ для провадження всебічного моніторингу

ЕСОЗ - основа для контрактування, оплати, моніторингу НСЗУ



НСЗУ – стратегічний закупівельник, який визначає

- Перелік та пріоритетність послуг, які плануються закуповуватись у наступних періодах
- Специфікацію та кількість послуг, що будуть закуповуватись
- Обсяг та періодичність виплат за послуги
- Кількість надавачів, що будуть надавати послуги
- Показники ефективності використання бюджетних коштів за програмою медичних гарантій!

НСЗУ формує потребу в закупівлі на основі даних

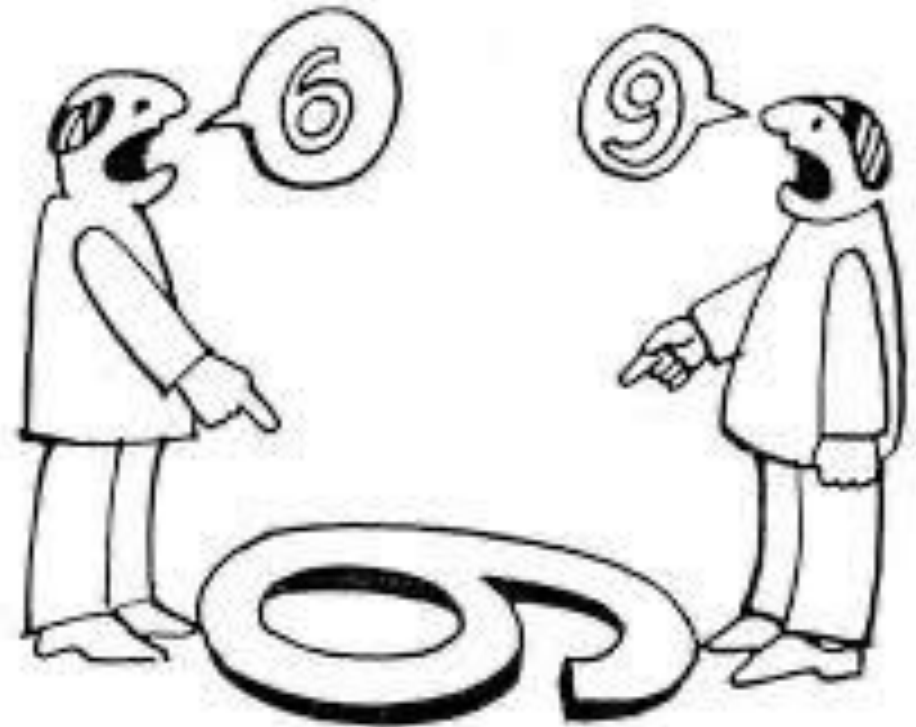
- Електронної системи охорони здоров'я
- Реєстрів
- Звітності встановленого зразка

Якість введених даних має прямий вплив на контактування та оплату від НСЗУ!



Що впливає на неприйняття звітів та подальше контактування?

- Вчасність введених даних
- Достовірність
- Відповідність послуги законтрактованому ЗОЗ пакету
- Відповідність кадрів та їх посадових обов'язків
- Завантаженість кадрів!
- Якість кодування!



Запитання до учасників:
Чи знаєте ви, який % з поданих до
НСЗУ звітів не були прийняті до
оплати у ЗОЗ, де обслуговуються
ваші мешканці?



Так, знаю



Ні, не знаю

Моніторинг на законодавчому рівні

1. [Закон України від 03.12.2019 №324-IX «Про моніторинг та верифікацію державних виплат»](#)
2. [Закон України від 05.07.1994 № 80/94 ВР «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»](#)
3. [Закон України від 01.07.2022 №2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги»](#)
4. [Постанова Кабінету Міністрів України в №807 від 19 липня 2022 року «Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров'я \(крім інформації про стан здоров'я людини\), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки»](#)
5. [Постанова Кабінету Міністрів України 1067 від 10 жовтня 2021 року «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров'я України та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»](#)



Моніторинг – перевірка достовірності даних

- **Відповідальними за автентичність інформації, що надається до інформаційно-аналітичної платформи, є суб'єкти надання інформації**
- Перевірка достовірності інформації проводиться згідно **Методики, затвердженої Мінфіном**
- Перевірка достовірності інформації та документів проводиться шляхом **автоматизованого обміну інформацією між центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я та інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу**
- **Мінфін** надає НСЗУ рекомендацію для проведення додаткової перевірки інформації, що містять невідповідність
- Мінфін не має доступу до інформації про стан здоров'я людини

Моніторинг у монітора

- Кількість наданих послуг на одного пацієнта
- Кількість на специфікацію направлень
- Географію наданих послуг
- Кількість послуг, наданих одним і тим самим лікарем та їх специфікацію
- Частоту звернень пацієнта
- Тривалість госпіталізацій
- % переведень в інші заклади
- Закупівлі закладу
- % покриття програмою доступні ліки
- Виконання контрактів в частині профілактичних заходів груп ризику



Якщо виявлено порушення?

Можливість проведення спільних заходів НСЗУ та КНП з метою покращити медичне обслуговування конкретним надавачем медичних послуг.

Для цього складають і підписують ПЛАН заходів з удосконалення медичного обслуговування.

НСЗУ може накласти штрафні санкції!!!

Санкції НСЗУ

НСЗУ може накласти штрафні санкції, зокрема:

- 0,5 % від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг, якщо буде виявлено невідповідності умовам закупівлі та специфікаціям
- 0,1 % від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок оплати пацієнтом безоплатних послуг
- 1 % від суми, яку НСЗУ сплатила за договором за кожний місяць, протягом якого план заходів з удосконалення медичного обслуговування не виконаний у повному обсязі

Увага!

- Оплата медичних послуг, що надавались без контрагування на відповідний пакет, **проводитись не буде**
- Тариф розраховано на оплату праці та закупівлю медикаментів з національного переліку та товарів медичного призначення
- Послуги закуповуються в тих закладах, де безпосередньо лікуються ваші мешканці

Запитання до учасників: Чи використовує ви знеособлені медичні дані в плануванні ?



Так,
використовуємо



Ні,
не використовуємо

Підходи до управління закладами охорони здоров'я з огляду на інфраструктурний етап реформи системи охорони здоров'я

**Хто відповідальний
за здоров'я громади
у вашій громаді?**

Збираємо дані!

1. Де задекларовані мешканці нашої громади?
2. До яких вузьких спеціалістів найчастіше виписують направлення лікарі первинної ланки?
3. Направлення на госпіталізацію?
4. Який % направлень погашається (по категоріях)?
5. Де погашаються ці направлення?
6. Де найближчі законтрактовані ЗОЗ, що надають ці послуги?

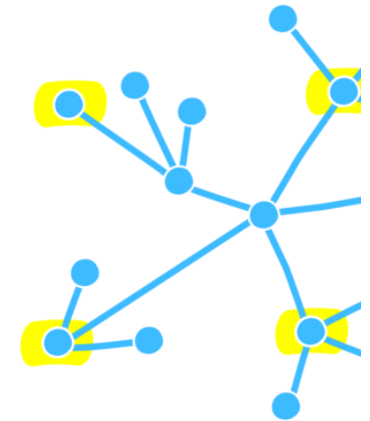
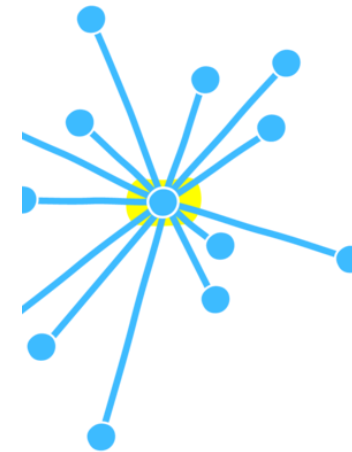
Що ми знаємо про шлях мешканців громад для отримання медичних послуг?

1. Скільки їм вартує дістатись до лікаря?
2. Чи витрачають вони додаткові кошти, щоби дістатись місця надання лабораторних та інших досліджень?
3. Чи існує можливість запису на прийом до лікаря чи на процедуру? Чи є черги?
4. Де можна отримати послугу вузького спеціаліста та процедуру, чи можна там записатись, чи треба «брати талончик»?
5. Скільки вартує дістатись до цих спеціалістів та як швидко можна до них потрапити?
6. Де можна придбати «Доступні ліки», скільки вартує дістатись до аптеки?

АНАЛІЗУЙТЕ У ПОРІВНЯННІ!

Централізація спеціалізованого рівня та децентралізація первинного

- Мешканці яких громад лікуються в нашій лікарні (консультації, лабораторні та діагностичні дослідження, госпіталізації)?
- Який це відсоток від загального об'єму виписаних направлень у тій чи іншій громаді?
- Хто ще надає медичні послуги за нашими напрямками в радіусі 60-90 хв?
- Яких додаткових спеціалізацій та обладнання можуть потребувати заклади первинного рівня?



Аналізуємо діяльність закладу станом на сьогодні, порівнюємо у динаміці

- Доля ринку за всіма видами послуг?
- Вартість медикаментів на один ліжко-день
- Вартість лікування за один ліжко-день
- Середня тривалість лікування
- Середня вартість пролікованого випадку по пакету у відділенні
- Середня оплата від НСЗУ за пролікований випадок по пакету у відділенні
- Питома вага адміністративних витрат у ...
- Середня ЗП медичного та немедичного персоналу по відділеннях
- Середня ЗП управлінців закладу
- Доля комунальних витрат у вартості одного випадка
- Зайнятість ліжок

**Не забуваємо обраховувати консультації,
лабораторні та діагностичні дослідження!**

Аналізуємо дані!

Який стратегічний напрямок розвитку нашої громади?



Яка прогнозована структура населення на довгострокову перспективу?



Яка прогнозована структура захворюваності?



З огляду на вищезазначені показники, які медичні послуги будуть найбільш затребувані?



Де ці послуги будуть надаватись?



Чи є медичні послуги цих ЗОЗ логістично та фінансово доступними для наших мешканців?



Чи їх інфраструктура готова до надання цих послуг?

Враховуємо!

- Профілактика – пріоритет первинного рівня
- Зменшення кількості контрактів для закладів з дублюючими послугами в єдиному територіальному просторі
- Розробляються нові вимоги до пакетів на 2024 рік
- Не оплачуються послуги, на які не законтрактовані заклади, навіть за умови їх надання
- Маршрути ЕМД побудовані та виконуються відповідно до принципу кластеризації
- Кількість електронної документації, що замінює паперову/дублює, збільшується щомісяця



Сусідні громади конкуренти чи можливі партнери?



Що може фінансувати місцеве самоврядування?

- Оновлення матеріально-технічної бази
- Капітальні ремонти
- Реконструкції
- Підвищення оплати праці працівників (програми «місцевих стимулів»)
- Надання населенню медичних послуг
- Місцеві програми громадського здоров'я
- Інші програми в охороні здоров'я

[Частина п'ятаб статті 3, Закон України від 19.10.2017 №2168-VIII](#)

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/2168-19>

Як діяти?

1. Створити наглядову раду, активно залучати її до процесу адаптації ЗОЗ до нових умов
2. Визначитись із мінімумом медичних послуг, який необхідний мешканцям громади
3. Визначитись зі шляхами пацієнтів до отримання цих послуг
4. Закріпити бачення ОЗ у документах громади
5. Розвивати навички персоналу у роботі з ЕСОЗ та електронними сервісами загалом
6. Організовувати отримання додаткових спеціалізацій медичного персоналу
7. Об'єднавшись приймати активну участь розробках маршрутів ЕМД госпітального округу
8. Напрацьовувати аналітику, на базі якої можливі зважені рішення щодо подальшого інвестування
9. Розбудовувати співпрацю
10. Зважено підходити до інвестування, в тому числі запитів на гуманітарну допомогу по обладнанню



Для тих, у кого все це вже виконано!

Розвивати сервіс!

Впроваджувати телемедичні
технології!

Індикатори визначення ефективності роботи ЗОЗ для ОМС на основі знеособлених електронних медичних даних

Актуально для всіх!



- Відсоток госпіталізацій по законтракованими НСЗУ напрямками із визначеної території (ринок послуг) - не менше 70%
- Відсоток госпіталізацій із громади власника закладу по законтракованими НСЗУ напрямками 85%
- Погашення направлень на консультації спеціалістів, проведення досліджень по законтракованими НСЗУ напрямками із визначеної території (ринок послуг) – не менше 80%

Кількість контрактів не визначає ефективність закладу!

- Яка прибутковість кожного із контрактів?
Все що не мінус – вже +!
- На який % зросла кількість наданих послуг за контрактом?
- Який % забракованих чи не оплачених випадків від НСЗУ в загальних за контрактом? Фінансові втрати?
- Яка доля медикаментів та товарів медичного призначення в загальному обсягу витрат по контракту?

Стратегічні пріоритети визначають індикатори ефективності

1. Рівень оплати праці лікарів, медичних сестер = 100-120%, ніж в середньому по регіону
2. Оновлення 20% комп'ютерної техніки на рік
3. % витрат на медикаменти в структурі витрат за надану послугу становить не менше 10%
4. Кількість ліжок, які обслуговує один пост середнього медичного персоналу, становить не більше 30 ліжок
5. Більше 2 ТГ приймають участь у ...



А що ж первинна ланка?

- Кількість візитів на одного задекларованого (щонайменше 1,5)
- Кількість проведених лабораторних досліджень на одного задекларованого (в залежності від пріоритету, але не менше 2)
- % охоплення профілактичними дослідженнями декларантів з груп ризику? (80%)
- Карта рівня щеплень за національним календарем щеплень (95%)
- Карта рівня екстреної госпіталізації з підозрою на інсульт, інфаркт, інсулінова кома, астма і т.д.
- Рівень виявлення та нозології онкопатологій. Рівень смертності в перший рік від виявлення

Стратегічні пріоритети визначають індикатори ефективності. Але як це реалізується?

Скорочення строку перебування пацієнта у
стаціонарних відділеннях (терапія)
до середньо-національного 8,6 діб

За рахунок чого це буде скорочено?

Протоколи лікування, нове високотехнологічне
обладнання, додаткові спеціалізації персоналу?

**Зазначте у чаті запитання
про управління закладом
ОЗ, на які ви б хотіли мати
індикатор ефективності**

Підсумки

1. Основний принцип формування та кластеризації госпітальних округів – маршрут пацієнта
2. Основа для контракування, оплати НСЗУ – якісно та вчасно введенні дані.
3. Підхід до управління закладами охорони здоров'я базується на аналізі потреб та місць отримання послуг мешканцями громади та співпраці громад-сусідів
4. Індикатори визначення ефективності роботи ЗОЗ для ОМС на основі знеособлених електронних медичних даних – основа планування заходів у сфері охорони здоров'я.



Питання відповіді



MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
OF DENMARK



Ministry
of Digital Transformation
of Ukraine



Ministry for Communities and
Territories Development of Ukraine

U-LEAD КОНСУЛЬТУЄ

З ЄВРОПОЮ

Facebook



Приєднуйтеся

у Facebook:

<https://bit.ly/U-LEADКонсультаує>

у Telegram:

<https://t.me/+XB75fAZpCABIOGMy>

Отримуйте відповіді на актуальні
питання від досвідчених експертів
Програми «U-LEAD з Європою»

Telegram



MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
OF DENMARK



Ministry
of Digital Transformation
of Ukraine



Ministry for Communities and
Territories Development of Ukraine